

Fecha Última Actualización: 19-07-2024 9:08:34

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Alejandro Esteban Sanchez Vega

Rut : 11.855.911-8

N° Archivo : 2219478

N° Epicrisis

406843

Edad : 53a 3m 5d

Fecha Nacto: 14/04/1971

Sexo : Masculino

Dirección : Pje Piedra Blanca 6491ciudad Del Este

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 6832 5073

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 18/07/2024 13:04

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 19/07/2024 09:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea de reposo, somnolencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

Alejandro Sanchez Vega

53 años

FI CASR: 18/07/24

FI UPC: 18/07/24

Contacto: Cristina Escobar, enfermera UPC

Antecedentes:

- Médicos: Insulino resistencia

-Medicamentos: (-)

-Alergias: (-)

-Quirurgicos: fractura clavícula derecho

-Hábitos: OH (-) Drogas (-) Tabaco: (-)

-Inmunización: COVID 4 dosis, Flu (+)

Historia clínica:

Pcte con antecedentes de IR, presenta cuadro iniciado el sábado 13/07 con síntomas respiratorios altos. Consulta en APS donde se diagnostica Virosis respiratoria probable influenza, quedando con manejo sintomático en domicilio. En las ultimas 48 hrs con deterioro clínico, iniciando disnea de esfuerzo progresiva y fiebre. Hoy es encontrado en sopor superficial y con disnea de reposo por lo que acude a UEA

Evaluable en malas condiciones generales, polipneico, uso de musculos accesorios, requerimientos de oxigeno y mala perfusion clinica con moteado hasta abdomen. Se decide hospitalizar en UCI

Ingresa en shock indiferenciado, adrenérgico, compensando con taquicardia 114 pm e hipertenso.

CRT 5 seg, moteado extenso de extremidades hasta abdomen. Vigil, atingente. HGT >300

Ecocopia con signos de precarga dependencia.

Se procede a monitorizar, invadir inicialmente 2 vvp para volemicación, LAI y apoyo de CNAF

En control de ISTAT: Ph 7.0, Bic 4, CO2 >20, K 2.2

Se invade con CVC pentalumén femoral derecho eco guiado al primer intento sin incidentes.

Fecha Epicrisis : 19/07/2024 09:08

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 19-07-2024 9:08:34

Página 2 de 4

Se indica mantener volemicación, Bicarbonato 2/3M y carga KCl10%.
Se continua reanimación y control de medio interno.

Examen físico de ingreso:

Perfusion: CRT> 4 seg, frío a distal. Mottling(4)
Piel y mucosas: rosado palido, mucosa oral seca
C y C: yug visible 90°, sin ingurgitacion
Torax: expande simetrico. Retraccion subcostal
C: RR2T sin soplos. 114 pm
P: MP (+) SRA
Abd: blando, depresible, indoloro. RHA+, sin signos peritoneales. Puño percusion(-)
EES: edema(-), pulsos ok
EEl: edema(-), sin signos TVP. Pedios+/-
Neuro: vigil, orientado TE, moviliza extremidades sin focalidad. Glasgow 15

Diagnósticos de ingreso:

1. Shock mixto: hipovolemico + distributivo x probable sepsis
->Disfuncion circulatoria + Insuficiencia respiratoria aguda + AKI KDIGO1 probable prerenalizacion
2. Cetoacidosis diabética: acidosis severa AG aumentado
3. Hipokalemia severa
4. Plaquetopenia en estudio
5. Obs NAC

Planes:

Hemodinamia: inestable, cursando disfuncion circulatoria aguda con signos clínicos de shock. En fase de compensación adrenérgica, taquicárdico, sin requerimientos de DVA. Eco bedside con adecuada contractilidad global y segmentaria, VD<VI, sin derrame pericardico. Derrame pleural bilateral
VCI pequeña. VTI 25.
En control de lab, lactato normal, no se dispone de GSV centrales. Hb>10
En suma, pcte con disfuncion circulatoria aguda, en fase de reanimación, con signos de precarga dependencia.
Plan: MI; volemicación generosa cristaloides y Alb. Vigilancia PAM>65. Correccion conjunta de medio interno con Bicarbonato.
Se termina de transfundir 2 U GR en contexto de uretrorragia tras instalación de CUP
Control parámetros de perfusion seriado.

Ventilatorio: pcte con insuficiencia respiratoria aguda, requiere de oxigeno suplementario para sat>94% y polipnea en relación a CAD, con PCO2 12 sobrecompensando BIC 3.5. De momento, se procede a apoyo con CNAF para Sat>94 y corrección de MI
Plan: control GSA y RxTx. Reevaluar necesidad de VMI

Infeccioso: antecedentes de síntomas respiratorios y fiebre, se sospecha NAC (Obs viral sobreinfectada)
Destaca PCR 342
Plan: se envían PCR COVID, PVR, HC 1 y 2. (P) URO. RxTx. Imagen con TAC tan pronto sea posible.
Empíricamente dejo terapia biasociada para NAC: AMS + AZT

Renal: leve disfuncion renal, no se cuenta con crea basal pero tiene Crea/bun 1.55/32 discreta prerenalizacion. Destaca hipoK 2.26
Se indica instalación de CUP, tras lo cual sale hematuria, se procede a su retiro, saliendo uretrorragia.
Se llama a urología.
Plan: monitorizar diuresis, volemicar contra metas. Carga de K y Bicarbonato. Controlar.

Metabolico: cuadro compatible con CAD, acidosis severa AG aumentado, hiperglicemia >400.
Se procede a reposicion de bicarbonato y de potasio previa a inicio de INSULINA
Plan: correccion de medio interno: bicarbonato/K. Una vez logrado kalemia normal, inicio de BIC Insulina

Fecha Epicrisis : 19/07/2024 09:08

Página 2 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:07

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 19-07-2024 9:08:34

Página 3 de 4

Hematológico: destaca ingreso con plaquetopenia 21.000

Plan: se indica Tx para llevar PQT>50.000

Profilaxis: IBP

Urológico: uretrorragia en pcte plaquetopenico. Urología intenta instalar SFoley, frusto.

Plan: corrección de plaquetas. Ante globo vesical, llamar a Cx de turno para cistostomía

Evolucion en UPC:

Dgs:

Shock septico, profundo, refractario a manejo medico

FOM

Disfuncion circulatoria aguda persistente

Insuficiencia respiratoria aguda catastrofica, global.

SDRA

Disfuncion renal aguda, anurico.

Acidosis metabolica severa, AG aumentado, Cetoacidosis diabetica

Hipoglicemia

Hipokalemia severa.

Bicitopenia: plaquetopenia + leucopenia x linfopenia

CID

Extrema gravedad.

Pcte con mala evolucion, refractario a medidas de reanimacion.

Ingreso con signos de precarga dependencia, volemezado con cristaloides y albumina 4%, persistiendo mala perfusion clinica y alza de lactato. Evolucion con vasoplejia severa, requerimientos de noradrenalina en dosis supratrapeuticas y vasopresina a 0.07 UI/ min, persistiendo con PAD <40

Medio interno profundamente alterado: ingresando con Ph 7.0, Bic 3.5, pco2 11, k 2.2, glicemias >400

Se procede a reposicion de potasio x vía central, solo logrando valores de 4.0 tras 18 grs KCl en total.

Calcio ionico bajo pese a reiterados aportes de cloruro Ca (6 ampollas) y gluconato de Ca (3 ampollas)

Acidosis mixta, bic < 15, Ph 7.0. Se administra bicarbonato sodio 2/3M, sin lograr optimizar valores.

Evolucionando rapidamente con falla respiratoria severa, menos polipnea con CNAF pero con RxTx que mostraba infiltrados multilobares. Se intuba aprox 16 hrs, sin mayores incidentes. Queda conectado a VM protectora pero evoluciona con rapido aumento de FiO2, mejor PEEP 5, hipercapnia, llegando a mantenerse con 100% FiO2, en estado de insuf respiratoria global progresiva, con O2 <60 y PCO2 >70.

TAC torax, multiples infiltrados condensantes bilaterales, neumonia multilobar. Sin potencial de reclutamiento alveolar.

Se decide pronó, realizandose 20 hrs. Evolucion sin mejoría del intercambio, con IRAg catastrofica persistente.

Anurico durante estadía en UCI

Informe de TAC TAP: Signos de extensa neumopatía multifocal bilateral con signos sugerentes de organización, de posible origen inflamatorio infeccioso. Algunos focos de condensación muestran morfología nodular, por lo que otro origen no es descartable, se recomienda controlar hasta resolución.

En exs destacando plaquetopenia desde su ingreso que no corrige pese a 2 pool de PQT (16 U en total)

Ultimo control de las 1 am, 8.000. Se vuelve a indicar Tx. Pruebas de coagulacion alteradas.

Se conversa caso con jefatura, se acuerda conexion a HFVVC como manejo de disfuncion circulatoria severa y persistente. A las 00:30 se conecta, evolucionando con hipotension, dosis supratrapeuticas de NAD y vasopresina, por lo que se agrega 3° DVA con adrenalina.

2:15 am se vuelve a supino.

Pcte queda con soporte HDM con triple DVA; se procede a reconexion a HFAV

Fecha Epicrisis : 19/07/2024 09:08

Página 3 de 4

En suma, pcte con falla circulatoria persistente, refractaria, shock profundo, hiperlactatemia persistente, hipoxica y adrenergica y con probable disminucion de clearance hepatico. En falla organica multiple, con insuficiencia respiratoria global catastrofica, disfuncion renal aguda anurica, CID, disfuncion hepatica.

Con plan de lograr condicion hemodinamica minima para soportes mas invasivos, con chance de HFAVC. Reevaluar en forma seriada respuesta. Ante indicios de respuesta favorable, se reevaluará condicion para soporte de intercambio gaseoso (ECMO VV)

A las 3 am se avisa de laboratorio HCs positivos a las 8 hrs para B G N . Se agrega a terapia antibiótica, Amikacina 1 gr ev

Pcte sigue con mala evolucion, sin lograr mejoras en medio interno, acidosis metabolica severa, ultimo control de Ph 6.7, PCO2 88, PO2 34, Bic 11, BE -24. Calcio ionico 1.8. Con noradrenalina que no se logra bajar de 1.2 mcg/kg/min, adrenalina 0.07 y vasopresina 0.07. CRT prolongado, moteado completo hasta cuello. Sin evidencia clinica de estabilidad con apoyo de HFCV. A las 4:20 am se satura filtro por lo que se debe desconectar a circuito.

Se conversa con esposa quien esta al tanto de gravedad de la situacion.

En suma, se revisa junto con ella evolucion torpida, sin mejoría ni estabilidad clinica

Persistencia de shock refractario, origen septico, bacteriemico x BGN. Disfuncion circulatoria persistente, vasoplejia refractaria, con triple droga vasoactiva y azul de metileno (2 ampollas), hiperlactatemia persistente mixta, disoxia tisular refractaria, sin respuesta a optimizacion de gasto cardiaco y transporte de oxigeno. Falla organica multiple, insuficiencia respiratoria catastrofica en neumonia multilobar. CID. Anuria.

En vista de lo expuesto, y ante falta de estabilidad clinica tras 4 hrs desde conexion a HFAV, con mayores aumentos de DVA y empeoramiento de acidosis mixta y FOM, se acuerda no volver a su conexion (futilidad de medida)

Se mantiene resto de soporte.

Desde las 8 am bradicardia complejo ancho.

Pcte con mala evolucion, refractario a manejo medico.

8:15 AESP. Se constata fallecimiento. En acompañamiento familiar

Diagnóstico de Egreso

Shock septico - FALLA ORGANICA MULTIPLE

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIMIENTO

Plan Post Alta

FALLECIMIENTO

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


María Valeria Medina Gatica
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 19/07/2024 09:08

Página 4 de 4